

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer normas e procedimentos para a Comunicação de Valores Críticos ao médico responsável, assim como a determinação dos limites críticos de cada analito observando a necessidade de comunicação, ação e meio de informação mais eficiente a ser aplicado, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ007- Reagentes
4.4. PQ012- Laudo Laboratorial
4.5. PQ013- Controle de dados e documentos
4.6. PQ015 – Biossegurança
4.7. PQ020- Satisfação do cliente
4.8. PQ032 - Plantão
4.9. PQ033- Exames Realizados com Urgência

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. CIQ – Controle interno de qualidade
- 5.2. CEQ – Controle externo de qualidade
- 5.3. PNCQ – Programa Nacional de Controle de Qualidade
- 5.4. AMC – Amostra Controle

6. DESCRIÇÃO DE FUNCIONALIDADE

- 6.1. Valores críticos são resultados que indicam patologias que devem receber atenção imediata do médico responsável. Muitos resultados críticos indicam perigo de vida para o paciente e devem ser comunicados imediatamente em caráter de urgência. Essa instrução define como e quando proceder à comunicação de resultados de forma emergencial.

7. APLICAÇÃO E PROCEDIMENTOS

7.1. Procedimento de comunicação de valores críticos

- 7.1.1. O colaborador responsável pela análise ou registro do resultado em laudo deve informar imediatamente a coordenação do laboratório quando algum valor crítico for encontrado.
- 7.1.2. Quando um valor crítico for encontrado, deve-se repetir o exame em duplicata ou sob observação de um colaborador diferente para confirmar se não se trata de uma anomalia, o que levaria a um falso resultado crítico.
- 7.1.3. Confirmado o resultado crítico, o médico ou instituição responsável deve ser informado. Isso pode ser realizado das seguintes formas:
 - 7.1.3.1. Por telefonema
 - 7.1.3.2. Pessoalmente
 - 7.1.3.3. Via laudo emitido sob caráter de urgência

7.2. Tabelas de Valores Críticos

- 7.2.1. Valores quantitativos em sangue de adultos e crianças que devem ser imediatamente comunicados ao médico solicitante ou responsável pelo paciente.

PARÂMETRO	VALOR CRÍTICO	INTERPRETAÇÃO
HEMATOLOGIA		

Instrução de Trabalho

Controle de Valores Críticos

Código:
ITS013

Versão:
3.0

Página:
3 de 9

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA)	Maior que 75 segundos	Deficiência ou inativação dos fatores VIII, IX, XI ou XII, com perigo de sangramento. Se o paciente estiver sob tratamento com Heparina, existe o perigo de sangramento se o TTPA estiver aumentado a um valor equivalente de mais de 2,5 vezes o limite superior do valor de referência.
Tempo de Protrombina	Maior que 40 segundos ou 3 vezes acima do nível normal	Risco de Hemorragia
Hematócrito	Menor que 18% Maior que 61%	Corresponde a uma concentração de Hemoglobina menor que 6,0 g/dL. O miocárdio recebe uma quantidade insuficiente de oxigênio. Significa uma intensa hiperviscosidade do sangue. A resistência ao fluxo circulatório está elevada; situação de ameaça de insuficiência cardíaca circulatória
Hemoglobina	Menor que 6,6 g/dL Maior de 19,9 g/dL	Os tecidos recebem insuficiente quantidade de oxigênio. Equivaler a um hematócrito de 61% e produz uma síndrome de hiperviscosidade.
Contagem de Plaquetas (adultos)	Menor que 20.000/mm ³ Maior que 1.000.000/mm ³	Risco de sangramento Risco de trombose
Contagem de Leucócitos	Menor que 2.000/mm ³ Maior que 50.000/mm ³	
BIOQUÍMICA		
Amilase	Maior que 200 U/L	Aneurisma aórtico abdominal, pancreatite crônica, obstrução do ducto biliar, obstrução

Instrução de Trabalho

Controle de Valores Críticos

Código:
ITS013

Versão:
3.0

Página:
4 de 9

		intestinal infecção supurativa, abscesso hepático, câncer hepático.
Aminotransferases (TGO/TGP)	Maior que 1.000 U/L	Dependendo da população que é atendida, deve ser feita a comunicação.
Fósforo (Fosfato inorgânico)	Menor que 1,0 mg/dL	Debilidade muscular, dores musculares, sintomas do sistema nervoso central tais como desorientação, confusão, convulsões, coma, insuficiência respiratória com acidose metabólica.
Bilirrubinas Totais	Maior que 15,0 mg/dL	Enfermidade hepatobiliar, produzida predominantemente por vírus hepatotrópico de origem infecciosa com perigo de contágio. Hemólise intra vascular.
Cálcio	Maior que 14,0 mg/dL Menor que 3,0 mg/dL	Perigo de crises hiper-calcêmicas que evoluem com sintomas tais como déficit de volume, encefalopatia metabólica e sintomas gastrointestinais O nível de concentração baixo pode levar a a tetania hipocalcêmica.
Cloro	Menor que 75 mmol/L Maior que 125 mmol/L	Indica uma alcalose metabólica considerável. Indica uma acidose metabólica primária maciça ou pseudo-hipercloremia, em caso de intoxicação por brometos.
Creatinina	Maior que 7,4 mg/dL	Insuficiência renal aguda, por exemplo, devido a uma insuficiência multi-órgano ou de uma sepse.
Creatinoquinase (CK-NAC)	Maior que 1.000 U/L	Dependendo da população que é atendida e da situação ao qual o exame foi solicitado (investigação de IMC por exemplo) deve ser feita a comunicação.
CK-MB	Maior que 30 UI	Infarto do miocárdio, embolia pulmonar, trauma cardíaco

Instrução de Trabalho

Controle de Valores Críticos

Código:
ITS013

Versão:
3.0

Página:
5 de 9

Glicose	Menor que 45 mg/dL Maior que 450 mg/dL	Sintomas Neurológicos de hipoglicemia, que podem estender-se desde uma diminuição da função cognitiva até a inconsciência. Coma diabético devido a falta de Insulina. Desenvolvimento de uma diurese osmótica com desidratação grave e cetoacidose diabética (Ácido β-hidroxibutírico menor que 5).
Lactato Desidrogenase (LDH)	Maior que 1.000 U/L	Dependendo população atendida, deve ser feita a comunicação.
Mioglobina	Positivo (Qualitativo) Maior que 110 mg/dL	Suspeita de infarto do miocárdio em pacientes com angina pectoris.
Potássio	Menor que 2,8 mEq/L Maior que 6,2 mEq/L	Obstrução intestinal, acidose metabólica, infecção aguda, necrose tubular aguda, falência cardíaca congestiva
Sódio	Menor que 120 mEq/L Maior que 160 mEq/L	Indica extremo transtorno da tonicidade (distribuição da água entre o espaço intracelular e extracelular) devido a um distúrbio do mecanismo da sede e/ou do hormônio antidiurético, da ingestão de água ou da capacidade de concentração e diluição renais. Os sintomas de uma hiponatremia intensa se devem a um déficit de volume. As manifestações principais de uma hipernatremia traduzem transtornos do sistema nervoso central como por exemplo desorientação, aumento da irritabilidade neuronamascular com espasmos e ataques convulsivos.
Troponina I	Positivo (Qualitativo) Maior que 1,6 ng/mL	Indica um infarto do miocárdio ou uma angina pectoris instável.
Acido Úrico	Maior que 13,0 mg/dL	Nefropatia aguda por Ácido Úrico, com bloqueio tubular à insuficiência renal. Em tal circunstância, o quociente Ácido

Instrução de Trabalho

Controle de Valores Críticos

Código:
ITS013

Versão:
3.0

Página:
6 de 9

		úrico/Creatinina na urina recente é maior que 1,0 mg/mg
Uréia	Maior que 214 mg/dL	Indicativo de insuficiência renal aguda, com aumento proporcional de Creatinina.
Tiroxina Livre (T4) Triiodotironina (T3)	Maior que 35 ng/L	Valores elevados de uma tireotoxicose, um estado clínico e laboratorial no qual os tecidos são submetidos a uma hiperconcentração de hormônios tireoideais ou que reagem frente a eles. Suas causa podem ser: Doença de Basedow, tumores trofoblásticos, adenoma hiperfuncionante da glândula tireoide, bócio nodular tireotóxico e raras vezes, uma hiperprodução de hormônio tireoestimulante (TSH)

7.2.2. Valores quantitativos em sangue de recém-nascidos que devem ser imediatamente comunicados ao médico solicitante ou responsável pelo paciente.

PARÂMETRO	VALOR CRÍTICO	INTERPRETAÇÃO
BIOQUÍMICA		
Bilirrubina total	Maior que 14 mg/dL	No primeiro dia de vida, indicador de doença hemolítica do recém-nascido; perigo de encefalopatia por bilirrubina
Proteína C Reativa (PCR)	Maior que 6 mg/L	Pode indicar uma sepse neonatal
Glicose	Menor que 30 mg/dL Maior que 325 mg/dL	Hipoglicemia, devido a transtorno congênito ou um hiperinsulinismo devido a diabetes melitus da mãe A concentração de Glicose menor que 25 mg/dL deve ser tratada mediante administração parenteral. Deve ser investigada com urgência a causa.

Instrução de Trabalho

Controle de Valores Críticos

Código:
ITS013

Versão:
3.0

Página:
7 de 9

Potássio	Menor que 2,6 mEq/L Maior que 7,7 mEq/L	Aparecimento de sintomas neuromusculares com hipo-reflexo e parálisis da musculatura respiratória Suas repercussões clínicas são os transtornos do ritmo cardíaco, debilidade da musculatura esquelética e paralisia respiratória.
IgM (para variados antígenos)	Positivo (qualitativo)	Pode indicar uma infecção intra-uterina
HEMATOLOGIA		
Hematócrito	Menor que 33% Maior que 71%	Indicador de uma anemia que pode levar a uma insuficiência de O₂ aos tecidos. Hiperviscosidade sanguínea com aumento da resistência circulatória
Hemoglobina	Menor que 8,5 g/dL Maior que 23 g/dL	Perigo de transtorno dos órgãos, especialmente quando existe ao mesmo tempo uma combinação de isquemia e hipóxia Cinética de fluxo anormal (hiperviscosidade), com aumento da resistência periférica vascular da circulação e sobrecarga funcional cardíaca.
Contagem de Leucócitos	Menor que 5.000/mm³ Maior que 25.000/mm³	Valores fora desses limites podem indicar a presença de uma infecção neonatal.
Contagem de Plaquetas	Menor que 100.000/mm ³	Em recém-nascidos de peso normal, um resultado desses deve ser investigado. Em crianças com peso inferior a 2,5 kg, o valor limite é de 50.000/mm ³

7.2.3. Resultados laboratoriais qualitativos críticos que devem ser imediatamente comunicados ao médico solicitante ou responsável pelo paciente.

Instrução de Trabalho

Controle de Valores Críticos

Código:
ITS013

Versão:
3.0

Página:
8 de 9

PARÂMETRO	VALOR CRÍTICO
Líquido Cefalorraquidiano (Líquor)	• Aumento da contagem celular • Leucocitose maior que 10/mm³, presença de células malignas • Glicose mais baixa que o soro • Detecção de microrganismos por coloração de gram • Proteína Total maior que 45,0 mg/dL
Urina	• Reação fortemente positiva para glicose e acetona na tira reagente • Presença de cilindros eritrocitários (hemáticos) ou presença de mais de 50% de hemácias deformadas • Hemoglobinúria sem eritrócitos no exame microscópico
Contagem diferencial de Leucócitos	• Reação leucemóide • Suspeita de leucemia • Suspeita de aplasia • Drepanocitose • Presença de agentes da malária • Presença de tripanossomíase
Microbiologia	• Detecção de microrganismos por coloração de Gram ou por cultura em exsudatos ou transudatos procedentes de cavidades corpóreas • Detecção de antígenos de agentes infecciosos, em testes rápidos como aglutinação por látex, • Detecção de BAAR • Detecção por cultura de salmonelas, <i>Shiguelas</i>, <i>Campilobacter</i>, <i>C. difficile</i>, <i>C. Perfringens</i>, <i>N. gonorrhoeae</i>, <i>B pertussis</i>, <i>N meningitides</i>, <i>C. diphtheriae</i>, assim como fungos como <i>Aspergillus</i> <i>Blastomyces</i>, <i>Coccidioides</i>, <i>Histoplasma</i> e <i>Cryptococcus</i>. • Hemocultura positiva.
Sorologia	• Reação cruzada incompatível • PCR acima do limite de detecção • Teste de antiglobulina direto e indireto (Coombs, PAI e TAD) positivo em espécime de rotina • Teste de Coombs positivo em cordão umbilical

Instrução de Trabalho

Controle de Valores Críticos

Código:
ITS013
Versão:
3.0
Página:
9 de 9

	• Títulos de hemácias alo-anticorpos significativos durante a gravidez • Reação de transfusão mostrando incompatibilidade de sangue transfundido • Teste positivo confirmado para hepatites, HIV e sífilis • Aumento dos níveis de anticorpos para agentes infecciosos.
--	---

7.3. Notificação e registro

7.3.1. O médico solicitante ou responsável pelo paciente deve ser informado imediatamente perante um valor crítico.

7.3.1.1. Em caso de não ser possível encontrar o médico solicitante ou um responsável pelo paciente apto a tomar decisões, deve-se notificar o agente de saúde público mais próximo do mesmo para que medidas sejam tomadas.

7.3.2. Essa notificação deve ser realizada segundo descrito na listagem do item 7.1.3 e registrada na FR014.

8. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR014 – Comunicação de valores críticos	Supervisor e profissionais da Área técnica	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano para o arquivo ativo e 5 anos para o arquivo morto

9. ANEXOS:

9.1. Não se aplica